BONUS 3

Protocollo per l'acufene somatosensoriale

Approccio integrato su ATM e rachide cervicale per l'acufene associato ai DTM

DURATA	SEDUTE	PREREQUISITO	MISURA
6 settimane	1 o 2 a settimana	Valutazione ORL	Disturbo 0 a 10

Criteri per sospettare un acufene somatosensoriale

- ☐ L'acufene si modifica con movimenti o contrazioni della mandibola o del collo
- ☐ Insorgenza o peggioramento insieme a dolore mandibolare o cervicale
- ☐ Fluttuazioni legate a postura, bruxismo o stress
- ☐ Udito normale o non spiegabile da sola ipoacusia

Prima di trattare

! **Valutazione obbligatoria.** Il paziente deve aver eseguito una valutazione otorinolaringoiatrica e audiologica. Acufene pulsante, unilaterale improvviso o con calo uditivo richiede invio medico urgente.

Test di modulazione

MANOVRA	EFFETTO SULL'ACUFENE
Serramento forte dei denti per 10 secondi	aumenta / diminuisce / invariato
Apertura massima e protrusione	aumenta / diminuisce / invariato
Contrazioni isometriche del collo in 4 direzioni	aumenta / diminuisce / invariato
Pressione sui trigger point di massetere e SCM	aumenta / diminuisce / invariato

Programma di 6 settimane

SETTIMANE	OBIETTIVO	INTERVENTI DEL KIT
1 e 2	Ridurre il carico	Educazione, autogestione, terapia miofasciale di massetere, temporale e SCM
3 e 4	Trattare il distretto	Terapia manuale dell'ATM e del rachide cervicale alto, flessori profondi
5 e 6	Consolidare	Esercizio domiciliare mandibolare e cervicale, gestione dello stress e del sonno

Monitoraggio

INDICATORE	INIZIO	SETTIMANA 3	SETTIMANA 6
Intensità dell'acufene (0 a 10)			
Disturbo nella vita quotidiana (0 a 10)			
Dolore mandibolare o cervicale (0 a 10)			

! **Aspettative realistiche.** L'obiettivo è ridurre intensità e disturbo dell'acufene, non garantirne la scomparsa. Comunica con chiarezza fin dalla prima seduta.

Riferimento

1. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.